E

RECURSO PROFESIONAL · PARA FAMILIAS Y EDUCADORES

Guía de Dislexia

En edad escolar · Detección, acompañamiento y adaptaciones

Revisado por logopeda colegiada

Espacio Lenguaje · Logopedia infantil basada en evidencia

www.espaciolenguaje.com

Guía de Dislexia en Edad Escolar

Detectar, entender y acompañar a tu hijo/a con criterios profesionales y basados en evidencia

---

Capítulo 1 · Qué es la dislexia

Entender la dislexia es el primer paso para ayudar. En este capítulo definimos el trastorno con criterios actuales y desmontamos los mitos que más confunden a familias y centros educativos.

Definición

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, de origen neurobiológico, que afecta principalmente a la precisión y la fluidez de la lectura de palabras, al deletreo y, con frecuencia, a la ortografía. Así la define el DSM-5 (APA, 2013) dentro del "Trastorno Específico del Aprendizaje con dificultad en la lectura" y así la recogen las guías internacionales de referencia (NICE, 2017; Snowling y Hulme, 2012).

Las cifras de prevalencia varían según los criterios diagnósticos y la lengua del estudio, pero se estima que la dislexia afecta entre el 5% y el 15% de la población escolar (DSM-5; Shaywitz, 2003). Dicho de otra forma: en un aula de 25 alumnos/as es esperable encontrar entre uno y tres niños con dislexia en algún grado.

La dislexia aparece en personas con una inteligencia dentro del rango de normalidad. Es importante aclarar este punto: el DSM-5 retiró el antiguo criterio de "discrepancia" entre cociente intelectual y rendimiento lector, porque la investigación ha demostrado que la dislexia no se identifica comparando CI con lectura, sino evaluando directamente la lectura y los procesos cognitivos que la sostienen (Pennington, 2009; Vellutino et al., 2004).

¿Qué ocurre en el cerebro?

Los estudios de neuroimagen muestran que, en la dislexia, las redes cerebrales del hemisferio izquierdo implicadas en el procesamiento fonológico y en la conversión grafema-fonema funcionan de manera menos eficiente (Shaywitz y Shaywitz, 2008). Eso explica que la decodificación lectora (traducir letras en sonidos) sea más lenta, costosa y propensa a errores, aunque el resto de capacidades cognitivas esté preservado.

Lo que la dislexia NO es

- **No es pereza.** Los niños con dislexia suelen esforzarse mucho más que sus compañeros para obtener resultados similares o inferiores.
- **No es falta de inteligencia.** La dislexia aparece en personas con inteligencia dentro del rango de normalidad.
- **No es culpa de una mala enseñanza.** Una enseñanza de calidad ayuda, pero la dislexia tiene una base neurobiológica y hereditaria.
- **No se cura, se compensa.** Con intervención adecuada, una persona con dislexia puede alcanzar cualquier meta académica y profesional.
- **No es "ver las letras al revés".** Es uno de los mitos más extendidos. Las inversiones puntuales son habituales durante los primeros años de lectoescritura en todos los niños; no son el rasgo definitorio de la dislexia.

> **Dato importante:** la dislexia tiene un fuerte componente hereditario. Si uno de los progenitores tiene dislexia, la probabilidad de que un hijo/a la presente se sitúa entre el 40% y el 60% (Snowling y Melby-Lervåg, 2016).

Tipos de dislexia

Existen varias clasificaciones. La más utilizada en la clínica distingue:

- **Dislexia fonológica:** dificultad para convertir letras en sonidos. Cuesta especialmente leer palabras nuevas o pseudopalabras.
- **Dislexia superficial:** dificultad para reconocer palabras de forma global. La lectura es muy lenta, letra a letra.
- **Dislexia mixta:** combinación de ambas. Es la más frecuente en castellano (Cuetos, 2010).

Una nota honesta sobre "fortalezas asociadas"

Circula la idea de que la dislexia viene acompañada de ventajas cognitivas sistemáticas: pensamiento visual excepcional, creatividad superior, mejor razonamiento espacial. Es un mensaje optimista y muy repetido, pero la evidencia actual no lo respalda como rasgo general del trastorno (Erbeli et al., 2022; Schneps, 2013). No existe un "perfil de fortalezas" empírico de la dislexia.

Lo que sí vemos en consulta, y hay que decirlo con cautela y sin convertirlo en regla, es que muchos niños y adolescentes con dislexia desarrollan recursos personales valiosos —perseverancia, estrategias creativas para resolver problemas, empatía por otros compañeros con dificultades— precisamente porque el camino ha sido exigente. No es una ventaja cognitiva intrínseca: es resiliencia aprendida. Conviene celebrarla sin disfrazarla de "superpoder".

> **Recuerda:** un diagnóstico de dislexia no es una sentencia, sino el primer paso para conseguir las herramientas y el apoyo adecuados. Cuanto antes se identifique, más eficaz será la intervención (Torgesen, 2004).

Capítulo 2 · Mitos y realidades

Antes de seguir, conviene desmontar con claridad las ideas erróneas que más circulan. Algunas parecen inofensivas y, sin embargo, llevan a familias a invertir tiempo y dinero en tratamientos sin base científica.

"La dislexia es ver las letras al revés"

Falso. Las inversiones de letras (b/d, p/q) forman parte del aprendizaje normal de la lectoescritura hasta los 7-8 años. Que un niño de 6 años confunda la b y la d no es, por sí solo, un marcador de dislexia. Lo relevante no es la inversión puntual, sino que los errores de lectura y escritura persistan más allá de los 7-8 años, sean frecuentes y afecten al rendimiento escolar.

"Las lentes o láminas de colores corrigen la dislexia"

Falso. El uso de filtros, lentes tintadas o láminas de colores (a menudo asociado al llamado "síndrome de Irlen" o "estrés visual") no tiene evidencia científica suficiente para recomendarse como tratamiento de la dislexia. La American Academy of Pediatrics (AAP, 2009) y la revisión sistemática de Evans y Allen (2016) concluyen que estos métodos no mejoran la lectura de manera específica ni consistente. La dislexia es un problema de procesamiento fonológico, no visual.

"Si lee, ya no tiene dislexia"

Falso. Muchos niños y adolescentes con dislexia compensan parcialmente la decodificación con el tiempo y la intervención, pero persisten dificultades en la ortografía, la velocidad lectora, la comprensión de textos largos y el aprendizaje de lenguas extranjeras.

"Es un problema que se pasa con la edad"

Falso. La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. Lo que cambia con la intervención no es el cerebro que la origina, sino las estrategias de compensación, la fluidez y la autoestima académica.

"Con esfuerzo basta"

Falso y, además, peligroso. El esfuerzo aislado, sin intervención especializada ni adaptaciones, suele derivar en ansiedad, baja autoestima y rechazo escolar. La dislexia requiere intervención específica: no se supera "leyendo más".

"Los métodos alternativos (patrones de gateo, kinesiología, reflejos primitivos) funcionan"

No hay evidencia científica que respalde estas aproximaciones como tratamiento de la dislexia. Los programas que sí cuentan con evidencia robusta son los de intervención fonológica sistemática y multisensorial tipo **Orton-Gillingham**, con eficacia respaldada por meta-análisis recientes (Stevens et al., 2021).

Capítulo 3 · Señales por edad

Las señales de dislexia varían según la etapa evolutiva. Conocerlas permite actuar a tiempo, sin alarmismos.

Preescolar (3-5 años)

A esta edad no se diagnostica dislexia, pero sí se pueden observar **señales de riesgo**:

- Dificultad con las rimas: le cuesta encontrar o completar palabras que rimen ("gato-pato").

- Confusión de sonidos similares al hablar (p/b, t/d, f/z).
- Inicio tardío del habla o vocabulario pobre para su edad.
- Dificultad para aprender el nombre y el sonido de las letras.
- Problemas para memorizar secuencias: días de la semana, números del 1 al 10, canciones.
- Antecedentes familiares de dislexia u otras dificultades lectoras.

> **Importante:** muchas de estas señales forman parte del desarrollo normal. Se consideran señales de alerta cuando se dan **varias a la vez** y **persisten** en el tiempo.

Primaria (6-9 años)

Es la etapa en la que la dislexia se hace más evidente, ya que las exigencias de lectura y escritura aumentan. Las señales dejan de considerarse "propias de la edad" a partir de los 7-8 años:

- Lectura lenta y laboriosa: silabea palabras que ya debería leer con fluidez.
- Errores de lectura que persisten más allá de los 7-8 años: omisiones, sustituciones, adivinación.
- Errores ortográficos frecuentes y persistentes: omite letras, las añade, cambia su orden ("pader" por "padre").
- Evita leer en voz alta: pone excusas, se pone nervioso, expresa rechazo.
- Dificultad para copiar de la pizarra: pierde el punto donde estaba, tarda mucho.
- Comprensión lectora pobre pese a entender bien lo mismo cuando se lo leen.
- Desorientación en lateralidad (izquierda/derecha) más allá de lo esperable.

Secundaria (10+ años)

En los últimos cursos de primaria y en secundaria muchas dificultades se han compensado en parte, pero aparecen nuevas:

- Comprensión lectora insuficiente en textos largos o complejos.
- Errores ortográficos persistentes a pesar de conocer las reglas.
- Escritura lenta; los exámenes escritos son un reto constante.
- Dificultad importante con idiomas extranjeros, especialmente inglés.
- Evitación de tareas que impliquen lectura o escritura.
- Gran desajuste entre rendimiento oral (a menudo bueno) y rendimiento escrito.

> **Señales emocionales a tener en cuenta:** frustración persistente, ansiedad ante los exámenes, rechazo escolar, autoexpresiones del tipo "soy tonto" o "no puedo". En

dislexia, las señales emocionales pesan tanto como las académicas y, muchas veces, son las primeras que percibe la familia.

¿Cuándo actuar?

Regla sencilla: si tienes dudas, consulta. Es mejor hacer una evaluación y que el resultado sea "desarrollo dentro de la normalidad" que dejar pasar señales importantes. La intervención temprana (antes de los 8 años) es la más eficaz (Torgesen, 2004), pero **nunca es tarde para empezar**.

Capítulo 4 · Checklist de detección

Una herramienta práctica para recopilar tus observaciones y compartirlas con el colegio y con profesionales. **No es un test diagnóstico**: es una guía de observación.

> Marca las señales que observes de forma habitual. Si marcas **3 o más en una franja de edad**, consulta con un logopeda o neuropsicólogo especializado.

Preescolar (3-5 años)

- ☐ Le cuesta encontrar o completar rimas.
- ☐ Confunde sonidos parecidos al hablar (p/b, t/d, f/z).
- ☐ Empezó a hablar más tarde que otros niños de su edad.
- ☐ Dificultad para aprender el nombre o el sonido de las letras.
- ☐ No recuerda secuencias (días, números en orden, canciones).
- ☐ Dificultad para aprender canciones o retahílas.
- ☐ Hay antecedentes familiares de dislexia o dificultades lectoras.

Primaria (6-9 años)

- ☐ Lee mucho más despacio que sus compañeros.
- ☐ Errores de lectura frecuentes que persisten más allá de los 7-8 años.
- ☐ Evita leer en voz alta o lo hace con gran ansiedad.
- ☐ Comete muchos errores ortográficos, incluso en palabras trabajadas.
- ☐ Le cuesta copiar de la pizarra y pierde el punto donde iba.
- ☐ No comprende bien lo que lee, aunque entiende lo mismo cuando se lo leen.
- ☐ Se desorienta con izquierda/derecha más de lo esperable para su edad.

Secundaria (10+ años)

- ☐ Necesita releer varias veces para entender un texto.
- ☐ Errores ortográficos persistentes pese a conocer las reglas.
- ☐ Escritura muy lenta en exámenes y tareas.
- ☐ Gran dificultad con idiomas extranjeros, sobre todo inglés.
- ☐ Evita tareas que impliquen leer o escribir.
- ☐ Baja autoestima académica o frustración frecuente.
- ☐ Rendimiento oral muy superior al escrito.

Ficha de observación

- Nombre del niño/a: _____
- Edad: _____ · Curso: _____ · Fecha: _____
- Observaciones adicionales: _____
- ¿Hay antecedentes familiares? Sí / No · ¿Quién?: _____

Capítulo 5 · Diferencias con otros trastornos

Es fácil confundir la dislexia con otras dificultades del aprendizaje o del lenguaje. Esta tabla comparativa te ayudará a entender las diferencias clave.

Característica	Dislexia	TDAH	TEL (Trastorno del Desarrollo del Lenguaje)	Discapacidad intelectual leve
A qué afecta principalmente	Lectura, escritura y ortografía	Atención, hiperactividad, impulsividad	Lenguaje oral (comprensión y/o expresión)	Todas las áreas académicas
Señal clave	Decodificación lectora lenta y errores fonológicos persistentes	No mantiene la atención, impulsividad, inquietud motora	Habla tardía, vocabulario pobre, frases mal estructuradas	Ritmo de aprendizaje globalmente más lento
Inteligencia	Dentro del rango de normalidad	Dentro del rango de normalidad	Dentro del rango de normalidad	Por debajo del rango de normalidad

Característica	Dislexia	TDAH	TEL (Trastorno del Desarrollo del Lenguaje)	Discapacidad intelectual leve
Quién diagnostica	Logopeda especializado y/o neuropsicólogo	Neuropediatra, psiquiatra infantil, psicólogo clínico	Logopeda, neuropsicólogo	Psicólogo clínico, equipo multidisciplinar
Edad habitual de detección	6-8 años	5-7 años	3-5 años	Variable

¿Pueden coexistir?

Sí, y con frecuencia. La comorbilidad entre dislexia y TDAH se estima en torno al 30-40% (Germanò et al., 2010; Willcutt y Pennington, 2000). Un porcentaje similar presenta además dificultades de lenguaje oral asociadas. Por eso, una evaluación completa debe valorar todas las posibilidades.

¿Por qué importa diferenciar?

Porque cada trastorno requiere una intervención específica:

- Un niño con dislexia necesita intervención fonológica sistemática y multisensorial (tipo Orton-Gillingham), trabajo de lectura y escritura y adaptaciones escolares.
- Un niño con TDAH puede necesitar abordaje médico, estrategias de autorregulación y organización.
- Un niño con TEL necesita intervención logopédica centrada en el lenguaje oral.

Cuando coexisten, el plan tiene que contemplar todas las áreas.

Capítulo 6 · Qué hacer si sospechas

Una ruta clara para pasar de la sospecha al plan de acción.

Ruta de actuación

1. **Habla con el tutor/a del colegio.** Comparte tus observaciones y pide las suyas. Pregunta si se ha hecho algún cribado lector.
2. **Consulta con el pediatra.** Descarta problemas de visión y de audición, que pueden imitar dificultades lectoras.
3. **Evaluación por un logopeda o neuropsicólogo especializado en lectoescritura.** Incluye lectura de palabras y pseudopalabras, velocidad y precisión lectora, comprensión, ortografía, conciencia fonológica, memoria de trabajo verbal y velocidad de denominación.
4. **Diagnóstico formal.** Informe con resultados, orientación diagnóstica según criterios DSM-5 y recomendaciones.
5. **Plan de intervención.** Logopedia especializada + adaptaciones escolares + pautas para casa.

¿Cuánto tarda todo el proceso?

Depende del contexto, pero en general: la evaluación completa suele tardar 2-4 sesiones (1-2 semanas de calendario). El informe escrito, 1-2 semanas más. La intervención conviene

iniciarla lo antes posible tras el diagnóstico.

¿Qué llevar a la primera consulta?

- Boletines de notas de los últimos cursos.
- Muestras de trabajos escolares donde se observen las dificultades (dictados, redacciones, copias).
- Informes previos, si los hay, del equipo de orientación o de profesionales.
- Tu checklist de observaciones (capítulo 4).
- Historial familiar de dificultades lectoras o de lenguaje.

¿Dónde buscar ayuda?

- **Equipo de orientación del colegio:** puede hacer una valoración inicial y proponer adaptaciones.
- **Logopeda especializado en lectoescritura:** es el profesional que trabajará directamente la lectura y la escritura.
- **Neuropsicólogo infantil:** realiza una evaluación cognitiva completa, útil para descartar o confirmar comorbilidades.
- **Asociaciones de dislexia:** ofrecen información, apoyo y recursos (FEDIS, Dislexia sin Barreras, asociaciones autonómicas).

> **Consejo:** no esperes a que el colegio tome la iniciativa. Si sospechas, actúa. Muchas familias pierden meses o incluso cursos esperando una evaluación pública. Una evaluación privada, aun siendo un coste, puede ahorrar mucho sufrimiento.

Capítulo 7 · Adaptaciones escolares

Medidas que el centro educativo puede y debe implementar con un diagnóstico que las justifique, para que el alumno/a pueda demostrar lo que realmente sabe. Están contempladas en la legislación educativa estatal y autonómica como adaptaciones **no significativas de acceso al currículo**.

En exámenes

- **Más tiempo:** entre un 25% y un 50% adicional.
- **Formato oral** cuando sea posible, como alternativa o complemento al escrito.
- **Uso del ordenador** para escribir respuestas (con corrector ortográfico desactivado si se evalúa la ortografía, o activado cuando no es el objetivo de la prueba).

- **Lectura en voz alta de los enunciados** por el profesor o un compañero.
- **No penalizar la ortografía** en materias que no sean Lengua, en línea con las orientaciones de atención a la diversidad.

En el aula

- **Sentarle en las primeras filas**, cerca de la pizarra y del profesor.
- **Fuentes y formato:** tipografías sans-serif estándar como **Arial o Verdana**, tamaño 14 puntos o superior, interlineado 1,5. Evitar columnas muy estrechas y textos en mayúsculas sostenidas. Las tipografías específicas tipo "OpenDyslexic" no cuentan con evidencia suficiente de superioridad frente a las sans-serif estándar (Kuster et al., 2018; Wery y Diliberto, 2017).
- **Apoyos visuales:** esquemas, mapas conceptuales, imágenes que acompañen al texto.
- **Reducir la copia desde la pizarra:** proporcionar el texto impreso o en formato digital.
- **Adaptar los deberes:** menos cantidad, priorizar calidad sobre cantidad.

Para los deberes en casa

- Dividir las tareas en bloques cortos (15-20 minutos) con descansos.
- Usar audiolibros como apoyo a la lectura.
- Permitir que dicte sus ideas antes de escribirlas.
- Usar mapas mentales y esquemas visuales para estudiar.
- Crear un espacio de estudio tranquilo y organizado.
- Celebrar los avances, por pequeños que sean.

Tecnología de apoyo

- **Text-to-speech:** programas que leen el texto en voz alta (Natural Reader, @Voice, lector integrado del sistema operativo).
- **Speech-to-text:** dictado por voz para reducir la barrera de la escritura (función nativa en iOS/Android y en Word/Google Docs).
- **Audiolibros:** plataformas comerciales y bibliotecas públicas digitales.
- **Apps específicas:** Dytective (cribado), Piruletras (ejercicios), Glifing (entrenamiento lector).

> **Recuerda:** las adaptaciones no son un privilegio, son un derecho reconocido por la normativa educativa. Un niño con dislexia sin adaptaciones es como un niño con miopía al que le retiran las gafas: no puede rendir según su verdadero potencial.

¿Cómo solicitarlas?

Pide una reunión con el tutor y el orientador escolar. Presenta el informe diagnóstico y solicita formalmente las adaptaciones por escrito. Guarda copia firmada. Si el centro no

responde, puedes elevar la petición a la dirección y, si persiste, a la inspección educativa.

Capítulo 8 · 10 ejercicios para casa

Actividades para reforzar lectoescritura de forma lúdica y sin presión. La mayoría trabajan **conciencia fonológica**, que es el predictor más robusto del aprendizaje lector (Melby-Lervåg et al., 2012) y el pilar de los programas con mayor evidencia, como Orton-Gillingham (Stevens et al., 2021).

1. Lectura compartida (10 minutos al día). Leed por turnos: tú una página, él/ella la siguiente. Si se atasca, ayúdale sin reproches. Prioriza el vínculo sobre el rendimiento.

2. Juego de rimas. Decid palabras y buscad rimas: "gato → pato → plato → rato". Se puede hacer en el coche o en la cena. Fortalece la conciencia fonológica.

3. Deletreo multisensorial. Escribid letras o palabras en bandejas con arena, arroz o sal. También con el dedo en la espalda para que adivine. Cuantos más sentidos se implican, mejor se consolida el aprendizaje (base del método Orton-Gillingham).

4. Lectura en voz alta con modelado. Tú lees un párrafo señalando las palabras; después él/ella lee el mismo párrafo. El modelado ofrece seguridad y muestra cómo suena una lectura fluida.

5. Segmentación y conteo de sonidos. Elige una palabra ("mesa") y pídele que dé una palmada por cada sonido (m-e-s-a = 4 palmadas). Variante: pídele que quite el primer sonido ("esa") o el último ("mes"). Es el ejercicio fonológico con más evidencia.

6. Dictado adaptado. Dicta frases cortas (3-5 palabras) con vocabulario conocido. El objetivo es que acierte, no que falle. Mejor 5 palabras bien escritas que 20 con errores.

7. Lectura con ventana o regla. Tapa las líneas de arriba y abajo con una regla o con un papel recortado. Ayuda a centrar la atención en la línea sin sobrecargar el campo visual.

8. Ordenar letras magnéticas. Forma palabras en la nevera y cambia una letra cada vez: "casa → masa → mesa → pesa". Trabaja la manipulación fonológica y la discriminación de sonidos.

9. Asociar palabra-imagen. Tarjetas con una palabra por una cara y un dibujo por la otra. Fomenta la lectura global como complemento de la fonológica, especialmente útil para palabras frecuentes.

10. Diario creativo (sin corregir). Anímale a escribir libremente: su día, un sueño, una historia inventada. Regla sagrada: **nunca se corrige**. El objetivo es que disfrute escribiendo.

Consejos generales

- **Poco y a menudo:** mejor 10 minutos al día que una hora el domingo.

- **Sin presión:** si está cansado o frustrado, parad. No es un castigo.
- **Celebra el esfuerzo**, no el resultado. "Me ha encantado lo que te has esforzado" vale más que "muy bien".
- **Varía las actividades:** la monotonía desmotiva.
- **Hazlo divertido:** si parece deberes, no funciona. Si parece un juego, sí.
- **Sé paciente:** los avances son lentos pero reales. Compara con él mismo, nunca con otros.

Capítulo 9 · Plantilla de informe para el tutor/a

Un documento para imprimir y entregar al tutor junto con el informe diagnóstico. Facilita la comunicación y la solicitud formal de adaptaciones.

Informe de observaciones para el tutor/a

Rellenar y entregar junto con el informe diagnóstico oficial.

- Nombre del alumno/a: _____
- Curso: _____ · Centro: _____
- Fecha: _____

Diagnóstico

- Diagnóstico: _____
- Profesional que diagnostica: _____
- Fecha del diagnóstico: _____

Dificultades observadas (marcar las que apliquen):

- ☐ Lectura lenta
- ☐ Errores ortográficos frecuentes
- ☐ Dificultad de comprensión lectora
- ☐ Errores de lectura persistentes (más allá de los 7-8 años)
- ☐ Dificultad para copiar de la pizarra
- ☐ Escritura lenta
- ☐ Baja autoestima académica
- ☐ Evitación de tareas de lectura
- ☐ Dificultad con idiomas extranjeros

- ☐ Otros: _____

Adaptaciones solicitadas (marcar las que apliquen):

- ☐ Más tiempo en exámenes (25-50%)
- ☐ Exámenes orales cuando sea posible
- ☐ Uso de ordenador para escribir
- ☐ No penalizar ortografía (excepto en Lengua)
- ☐ Material impreso (evitar copia de pizarra)
- ☐ Fuente adaptada: sans-serif (Arial/Verdana), tamaño 14+, interlineado 1,5
- ☐ Sentarse en primera fila
- ☐ Reducción de cantidad de deberes
- ☐ Lectura de enunciados en voz alta
- ☐ Otras: _____

Firmas

- Padre/madre/tutor legal: _____ Fecha: _____
- Tutor/a: _____ Fecha: _____
- Orientador/a: _____ Fecha: _____

Capítulo 10 · Preguntas frecuentes y glosario

Preguntas frecuentes

¿La dislexia se cura? No se "cura" porque no es una enfermedad: es una forma diferente de procesar el lenguaje escrito, de base neurobiológica. Con intervención adecuada, se aprenden estrategias compensatorias que permiten leer y escribir con eficacia. Muchos adultos con dislexia alcanzan niveles académicos y profesionales altos.

¿A qué edad se puede diagnosticar? El diagnóstico formal suele hacerse a partir de los 6-7 años, cuando el aprendizaje de la lectura está en marcha (criterio DSM-5). Antes se pueden detectar **señales de riesgo** y hacer intervención preventiva en conciencia fonológica.

¿Es hereditaria? Sí. Si uno de los progenitores tiene dislexia, la probabilidad de transmisión se sitúa entre el 40% y el 60% (Snowling y Melby-Lervåg, 2016).

¿Los niños con dislexia son más creativos? No existe evidencia científica que respalde una ventaja cognitiva sistemática (creatividad, pensamiento visual, razonamiento espacial) asociada a la dislexia (Erbeli et al., 2022). Muchos niños y adolescentes con dislexia desarrollan recursos personales valiosos, pero conviene no reforzar un "mito positivo" que, además, puede desatender las dificultades reales.

¿Las gafas o láminas de colores ayudan? No cuentan con evidencia suficiente como tratamiento de la dislexia (AAP, 2009; Evans y Allen, 2016). Si un niño refiere fatiga visual, lo adecuado es una revisión oftalmológica y optométrica, no un filtro de color. La dislexia es un trastorno fonológico, no visual.

¿Existe una fuente tipográfica específica para dislexia? No de forma concluyente. Las revisiones disponibles no muestran superioridad clara de fuentes tipo "OpenDyslexic" frente a sans-serif estándar (Kuster et al., 2018; Wery y Diliberto, 2017). Lo que sí ayuda: Arial o Verdana, tamaño 14+, interlineado 1,5 y buen contraste.

¿Qué intervención tiene más evidencia? Los programas de intervención fonológica sistemática y multisensorial, tipo **Orton-Gillingham**, cuentan con el mayor respaldo en meta-análisis recientes (Stevens et al., 2021). En castellano, los programas basados en conciencia fonológica y correspondencia grafema-fonema son los de referencia (Cuetos, 2010; Defior et al., 2015).

¿Mi hijo/a podrá ir a la universidad? Sí. Las universidades disponen de servicios de atención a la diversidad con adaptaciones para estudiantes con dislexia. La clave está en la intervención temprana, las estrategias compensatorias y el acompañamiento emocional.

Glosario de términos

Término	Definición
Conciencia fonológica	Capacidad de identificar y manipular los sonidos del lenguaje oral. Es el predictor más robusto del aprendizaje lector.
Decodificación	Proceso de convertir letras escritas en sonidos y palabras. En dislexia es lenta y costosa.
Dificultad específica del aprendizaje (DEA)	Trastorno del neurodesarrollo que afecta a un área concreta del aprendizaje (lectura, escritura, cálculo), en personas con inteligencia dentro del rango de normalidad.
Disgrafía	Dificultad específica para la escritura (trazo, grafía). Puede coexistir con la dislexia.
Disortografía	Dificultad específica para la ortografía. Muy frecuente en dislexia.
DSM-5	Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5ª ed., APA, 2013). Sistema diagnóstico de referencia.
Lectura fonológica	Lectura que convierte cada letra en su sonido. Ruta necesaria para palabras nuevas o desconocidas.
Lectura global (léxica)	Reconocimiento de palabras enteras "de un vistazo", sin decodificar letra a letra. Ruta dominante en lectores expertos.

Término	Definición
Orton-Gillingham	Enfoque de intervención fonológica sistemática, explícita y multisensorial para dislexia, con evidencia respaldada por meta-análisis.
Pseudopalabra	Palabra inventada que respeta las reglas de la lengua (p. ej., "felumo"). Se usa en evaluación para medir decodificación pura.
TDAH	Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Puede coexistir con la dislexia (30-40%).
TEL / TDL	Trastorno Específico / del Desarrollo del Lenguaje. Afecta al lenguaje oral (comprensión y/o expresión).
Velocidad de denominación	Rapidez para nombrar estímulos conocidos (letras, números, colores, objetos). Otro predictor importante del aprendizaje lector.

Carta a las familias

Si estás leyendo esta guía es porque sospechas que tu hijo o hija puede tener dislexia, o porque ya tiene un diagnóstico y quieres entender cómo acompañarle mejor.

Queremos que sepas que no estás solo. Miles de familias pasan por este mismo camino y, con información rigurosa y apoyo profesional, el recorrido se hace mucho más llevadero.

Tu hijo/a tiene muchas fortalezas y la dislexia es solo una pieza más de quién es, no le define. Con paciencia, comprensión, intervención adecuada y las adaptaciones que le corresponden por derecho, puede llegar a donde se proponga.

Si necesitas orientación profesional, en Espacio Lenguaje ofrecemos evaluación, intervención y acompañamiento a familias, siempre desde la evidencia científica y el respeto por los tiempos del niño.

El primer paso es el más importante y ya lo has dado: informarte bien.

Referencias

- American Academy of Pediatrics (AAP), Council on Children with Disabilities, Section on Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus,

American Academy of Ophthalmology (2009). *Joint Statement — Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision*. Pediatrics, 124(2), 837-844.

- American Psychiatric Association (APA) (2013). *DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). APA Publishing.
- Cuetos, F. (2010). *Psicología de la lectura*. Wolters Kluwer.
- Defior, S., Serrano, F. y Gutiérrez-Palma, N. (2015). *Dificultades específicas del aprendizaje*. Síntesis.
- Erbeli, F., Rice, M. y Paracchini, S. (2022). *Insights into Dyslexia Genetics Research from the Last Two Decades*. Brain Sciences, 12(1), 27.
- Evans, B. J. W. y Allen, P. M. (2016). *A systematic review of controlled trials on visual stress using Intuitive Overlays or the Intuitive Colorimeter*. Journal of Optometry, 9(4), 205-218.
- FEDIS — Federación Española de Dislexia y otras DEA. Recursos y divulgación: fedis.org.
- Germanò, E., Gagliano, A. y Curatolo, P. (2010). *Comorbidity of ADHD and Dyslexia*. Developmental Neuropsychology, 35(5), 475-493.
- Kuster, S. M., van Weerdenburg, M., Gompel, M. y Bosman, A. M. T. (2018). *Dyslexie font does not benefit reading in children with or without dyslexia*. Annals of Dyslexia, 68, 25-42.
- Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H. y Hulme, C. (2012). *Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review*. Psychological Bulletin, 138(2), 322-352.
- NICE — National Institute for Health and Care Excellence (2017). *Learning disabilities and behaviour that challenges: service design and delivery (NG93)*. Reino Unido.
- Pennington, B. F. (2009). *Diagnosing Learning Disorders: A Neuropsychological Framework* (2nd ed.). Guilford Press.
- Real Patronato sobre Discapacidad (Ministerio de Derechos Sociales, Gobierno de España). Documentos técnicos sobre dificultades específicas de aprendizaje.
- Schneps, M. H. (2013). *The Advantages of Dyslexia*. Scientific American Mind (análisis crítico de la evidencia).
- Serrano, F. y Defior, S. (2008). *Dyslexia speed problems in a transparent orthography*. Annals of Dyslexia, 58(1), 81-95.
- Shaywitz, S. E. (2003). *Overcoming Dyslexia*. Vintage Books.
- Shaywitz, S. E. y Shaywitz, B. A. (2008). *Paying attention to reading: The neurobiology of reading and dyslexia*. Development and Psychopathology, 20(4), 1329-1349.
- Snowling, M. J. y Hulme, C. (2012). *The Science of Reading: A Handbook*. Wiley-Blackwell.
- Snowling, M. J. y Melby-Lervåg, M. (2016). *Oral language deficits in familial dyslexia: A meta-analysis and review*. Psychological Bulletin, 142(5), 498-545.
- Stevens, E. A., Austin, C., Moore, C., Scammacca, N., Boucher, A. N. y Vaughn, S. (2021). *Current State of the Evidence: Examining the Effects of Orton-Gillingham Reading Interventions for Students with or at Risk for Word-Level Reading Disabilities*. Exceptional Children, 87(4), 397-417.
- Torgesen, J. K. (2004). *Lessons Learned from Research on Interventions for Students Who Have Difficulty Learning to Read*. En P. McCardle y V. Chhabra (Eds.), *The Voice of*

Evidence in Reading Research. Brookes Publishing.

- Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J. y Scanlon, D. M. (2004). *Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades?* Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 2–40.
- Wery, J. J. y Diliberto, J. A. (2017). *The effect of a specialized dyslexia font, OpenDyslexic, on reading rate and accuracy*. Annals of Dyslexia, 67, 114–127.
- Willcutt, E. G. y Pennington, B. F. (2000). *Comorbidity of reading disability and attention-deficit/hyperactivity disorder*. Journal of Learning Disabilities, 33(2), 179–191.

E

Más recursos en espaciolenguaje.com

Blog clínico · Guías descargables · Pack Completo con todos los recursos del equipo.

© Espacio Lenguaje · Uso personal. No redistribuir.